STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENANGANAN SYOK ANAFILAKTIK

2024

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
Jl. Cikapayang No.5, Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40116
Telp/ Fax. 022-4219305, E-mail : balaikarkesbandung@kemkes.go.id

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung
Jl. Cikapayang No.5, Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40116
Telp/ Fax. 022-4219305, E-mail : kkpbandung@yahoo.com

Nomor SOP	OT.02.02/C.X.5 / 2282 /2024
Tgl. Pembuatan	Kamis, 08 Agustus 2024
Tgl. Revisi	
Tgl. Efektif	11 Agustus 2024
Disahkan oleh	Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung **dr. Sesa Dwisangka, M.Epid** NIP. 196901042002121003
Judul SOP	PENANGANAN SYOK ANAFILAKTIK

DASAR HUKUM

1. International Health Regulation 2005 ;
2. UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;
3. KMK No HK.01.07-MENKES-2598-2020 tentang Peta Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan
4. KMK_No._HK.01.07-MENKES-2149-2023 Tentang Urairan Tugas dan Fungsi Organisasi Pembentukan Tim Kerja Bidang Kekarantinaan Kesehatan
5. KMK no HK 01 07 Menkes 5 2024 Tentang Pedoman Identitas Kemenkes
6. Permenkes RI No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
7. Permenkes RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.
8. Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/3717/2024 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haii dan Umrah.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan penanganan gawat darurat
2. Memiliki sertifikat ACLS (bagi dokter)
3. Memiliki sertifikat BTCLS (bagi perawat)
4. Memahami langkah-langkah penanganan syok anafilaktik

KETERKAITAN

1. SOP Pelayanan Vaksinasi Internasional
2. SOP Penyimpanan Vaksin
3. SOP Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)
4. SOP SDM Pelayanan Vaksinasi

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Peralatan :

1. Informed consent
2. Oximetri
3. Stetoskop
4. Tensimeter
5. Tabung oksigen
6. Simpel mask / nasal kanul
7. Termometer
8. Handschoon
9. Infusion set
10. Handsanitizer
11. Ambulance
12. ATK

Bahan :

1. Adrenalin 1:1000
2. Dexamethasone ampul
3. Diphenhydramine vial
4. Aminofilin ampul
5. Atropin sulfas
6. Syringe 3 cc 1 pcs
7. Wing needle 25 1 pcs
8. Syring 5 cc 1 pcs
9. Abbocath no 24 1 pcs
10. Nacl 100 ml 1 botol
11. Syringe 1 cc 3 pcs
12. Cairan RL 500 ml 1 pcs
13. Cairan Nacl 500 ml 1 pcs

PERINGATAN

1. Jika prosedur tidak dilaksanakan maka dapat mengancam jiwa — dapat menghentikan pernapasan atau detak jantung Anda.
2. Jika prosedur tidak dilaksanakan maka setelah seseorang mengalami syok anafilaksis, sistem kekebalan tubuhnya menjadi sensitif, sehingga mereka lebih rentan terhadap reaksi alergi parah di masa mendatang.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

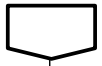
1. Disimpan sebagai data secara manual dan softcopy

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung

PENANGANAN SYOK ANAFILAKTIK

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Dokter	Perawat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Dokter melakukan pemeriksaan dan advice untuk menghentikan pencetus & melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital			Stetoskop, tensimeter, oxymetri	1 menit	diperoleh gambaran penyakit (syok anafilaktik)	
2	Memberikan injeksi Adrenalin (epinefrin) 1:1000 pada regio midanterolateral paha 0,01 mg / kg BB sampai maksimal 0,5 mg dewasa atau 0,3 mg anak, subkutan atau im; catat waktu pemberian dosis dapat diulang 2-3 kali dengan jarak 15 menit			handscoon, spuit & needle 3 cc, adrenalin (epinefrin) injeksi ampul	5 menit	reaksi syok berkurang	
3	Letakkan pasien dalam posisi telentang atau pada posisi paling nyaman jika terdapat distres pernafasan atau muntah dengan elevasi ektremitas bawah (kecuali kalau pasien sesak). Kejadian fatal dapat terjadi dalam beberapa detik jika pasien berdiri atau duduk tiba-tiba.			bed pasien, bantal untuk elevasi ektremitas bawah	1 menit	memaksimalkan aliran darah ke arah jantung & paru	
4	Mengawasi jalan napas pasien, memeriksa tanda-tanda vital setiap 15 menit			Stetoskop, tensimeter, oxymetri	15 menit	tanda-tanda vital terawasi dengan baik	
5	Jika diperlukan berikan oksigen aliran tinggi (6-8 liter/ menit) dengan masker atau oropharyngeal airway.			Tabung oksigen, masker nasal kanul	5 menit	oksigen terpasang	
6	Memberikan akses intravena, jika diperlukan berikan 1-2 liter cairan NaCl 0,9 % (isotonik) dengan cepat (5-10 ml/kg BB pada 5-10 menit awal pada orang dewasa; 10 ml/kg BB pada anak-anak.			Infus set, abbocath sesuai ukuran, handschoon, cairan infus RL atau NaCL 0,9%	5 menit	infus terpasang	
7	Bila efek terhadap adrenalin kurang, memberikan difenhidramin hidroklorida, 1 mg/ kg BB sampai maksimal 50 mg im atau iv perlahan-lahan			spuit & needle 3 cc, difenhidramin hidrokloride injeksi vial, handscoon	1 menit	reaksi syok berkurang	
8	Bila terjadi hipotensi (tekanan sistol < 90 mm Hg), memberikan cairan iv yang cukup			Stetoskop, tensimeter, infus set, kapas alkohol, abocath sesuai ukuran, torniquet, handschoon, plester, gunting plester, bengkok, cairan infus RL atau NaCL 0,9%	10 menit	infu terpasang dengan tetesan 16 tpm	
9	Bila tidak ada respon, memberikan dopamin 400 ug (2 ampul) dalam cairan infus Ringer Lactat atau NaCl 0,9%, untuk mempertahankan tekanan darah sistolik 90-100 mmHg			Dopamin inj 2 ampul, spuit & needle 3 cc, kapas alkohol	2 menit	reaksi syok berkurang	
10	Bila terjadi bronkospasme persisten, memberikan oksigen 4-6 liter / menit,			Tabung Oksigen, selang oksigen	5 menit	oksigen terpasang	

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung

11	Bila tidak terjadi hipotensi, memberikan aminofilin 6 mg/kg iv selama 15-20 menit,			Aminofilin inj ampul, spuit & needle 3 cc	1 menit	hipotensi teratasi	
12	Untuk mencegah relaps (reaksi fase lambat), memberikan hidrokortison 7-10 mg/kg iv			Hidrokortison inj, ampul, spuit & needle 3 cc	1 menit	keadaan pasien stabil	
13	Monitor tekanan darah pasien, denyut dan fungsi jantung, status pernafasan dan oksigenasi pasien sesering mungkin dalam interval reguler.			stetoskop, tensimeter, oxymetri, oksigen	10 menit	tanda-tanda vital stabil	
14	Jika diperlukan, lakukan resusitasi kardiopulmoner dengan kompresi dada secara kontinyu dan amankan pernafasan			ambubag	10 menit	tanda-tanda vital stabil	
15	Dokter memberikan advice untuk melakukan rujukan apabila diperlukan penanganan lebih lanjut			Ambulance rujukan	20 menit	penatalaksanaan lanjutan di RS rujukan	
16	Setelah melaksanakan tatalaksana syok anafilaktik lakukan pencatatan dan pelaporan			Formulir rekam medis	20 menit	laporan rekam medis	

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung

LANGKAH KERJA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN SYOK ANAFILAKTIK
OT.02.02/C.X.5 / 2282 /2024

No	LANGKAH KERJA	KELENGKAPAN	KETERANGAN
1	Menghentikan pencetus & melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital	Stetoskop, tensimeter, oxymetri	
2	Memberikan injeksi Adrenalin (epinefrin) 1:1000 pada regio midanterolateral paha 0,01 mg / kg BB sampai maksimal 0,5 mg dewasa atau 0,3 mg anak, subkutan atau im; catat waktu pemberian dosis dapat diulang 2-3 kali dengan jarak 15 menit	handscoon, spuit & needle 3 cc, adrenalin (epinefrin) injeksi ampul	
3	Letakkan pasien dalam posisi telentang atau pada posisi paling nyaman jika terdapat distres pernafasan atau muntah dengan elevasi ektremitas bawah (kecuali kalau pasien sesak). Kejadian fatal dapat terjadi dalam beberapa detik jika pasien berdiri atau duduk tiba-tiba.	bed pasien, bantal untuk elevasi ektremitas bawah	
4	Mengawasi jalan napas pasien, memeriksa tanda-tanda vital setiap 15 menit	Stetoskop, tensimeter, oxymetri	
5	Jika diperlukan berikan oksigen aliran tinggi (6-8 liter/ menit) dengan masker atau oropharyngeal airway.	Tabung oksigen, masker nasal kanul	
6	Memberikan akses intravena, jika diperlukan berikan 1-2 liter cairan NaCl 0,9 % (isotonik) dengan cepat (5-10 ml/kg BB pada 5-10 menit awal pada orang dewasa; 10 ml/kg BB pada anak-anak.	Infus set, abbocath sesuai ukuran, handschoon, cairan infus RL atau NaCL 0,9%	
7	Bila efek terhadap adrenalin kurang, memberikan difenhidramin hidroklorida, 1 mg/ kg BB sampai maksimal 50 mg im atau iv perlahan-lahan	spuit & needle 3 cc, difenhidramin hidrokloride injeksi vial, handscoon	
8	Bila terjadi hipotensi (tekanan sistol < 90 mm Hg), memberikan cairan iv yang cukup	Stetoskop, tensimeter, infus set, kapas alkohol, abocath sesuai ukuran, torniquet, handschoon, plester, gunting plester, bengkok, cairan infus RL atau	
9	Bila tidak ada respon, memberikan dopamin 400 ug (2 ampul) dalam cairan infus Ringer Lactat atau NaCl 0,9%, untuk mempertahankan tekanan darah sistolik 90-100 mmHg	Dopamin inj 2 ampul, spuit & needle 3 cc, kapas alkohol	

10	Bila terjadi bronkospasme persisten, memberikan oksigen 4-6 liter / menit,	Tabung Oksigen, selang oksigen	
11	Bila tidak terjadi hipotensi, memberikan aminofilin 6 mg/kg iv selama 15-20 menit,	Aminofilin inj ampul, spuit & needle 3 cc	
12	Untuk mencegah relaps (reaksi fase lambat), memberikan hidrokortison 7-10 mg/kg iv	Hidrokortison inj, ampul, spuit & needle 3 cc	
13	Monitor tekanan darah pasien, denyut dan fungsi jantung, status pernafasan dan oksigenasi pasien sesering mungkin dalam interval reguler.	stetoskop, tensimeter, oxymetri, oksigen	
14	Jika diperlukan, lakukan resusitasi kardiopulmoner dengan kompresi dada secara kontinyu dan amankan pernafasan	ambubag	
15	Melakukan rujukan	Ambulance rujukan	
16	Melakukan pencatatan dan pelaporan	Formulir rekam medis	